



جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الكوفة / كلية التربية للبنات

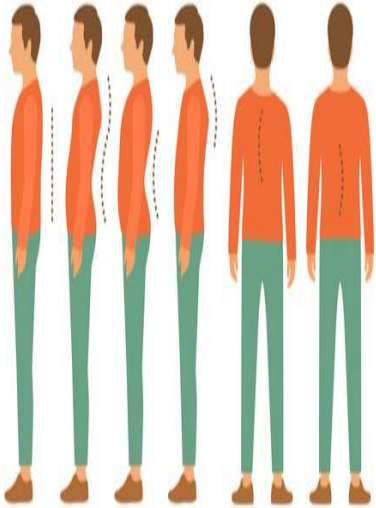
قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

الدراسات العليا/ الدكتوراه

التشوهات القوامية والاصابات الشائعة

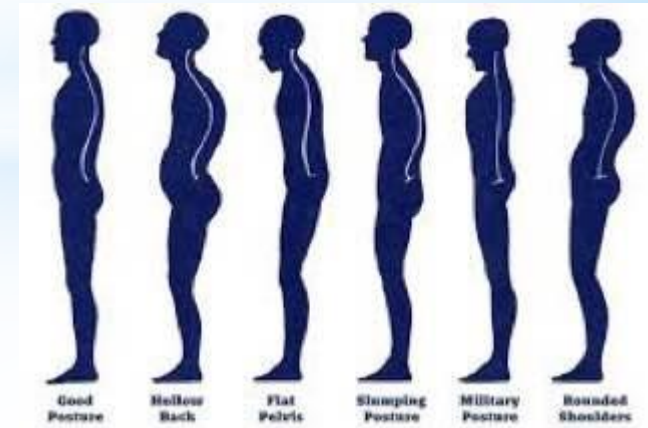
محاضرة مقدمة من قبل الطالبة

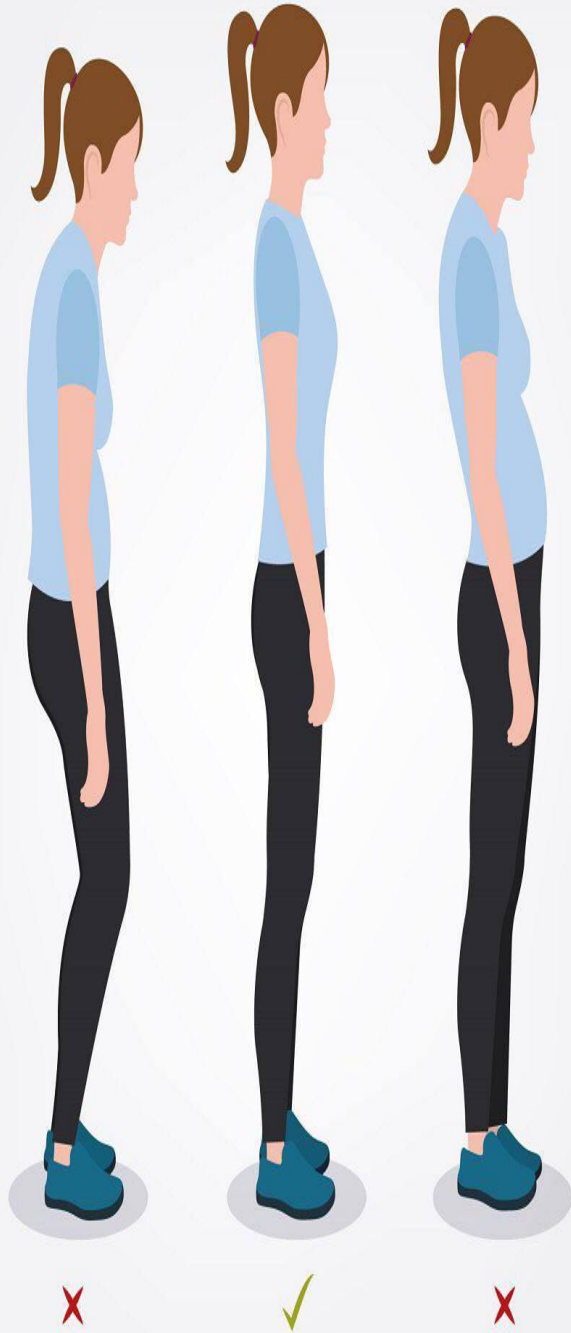
بيداء كريم فليح



بإشراف

أ. د. محمد جاسم محمد الخالدي





مدخل إلى التشوهات القوامية:

"يحتل جسم الإنسان الصفة الميكانيكية بين أجزاء الجسم العضلية والعظمية والعصبية لإعطاء صفة التعاون والترابط بين هذه الأجهزة لتحقيق الاتزان مع بذل الحد الأدنى من الطاقة فان حدوث أي خلل في هذا الترابط يؤدي إلى حدوث ما يعرف بالتشوه القوامي، وان التشوهات القوامية تعد عاملاً مساعداً وأساساً في حدوث الإصابات الرياضية بالنسبة للرياضي

Postural deformities: which is a deviation or change in the shape of a member of the whole body or part of it from the normal shape recognized anatomically, as it means “an imbalance in the freedom of parts of the body and the departure of the center of gravity from the vertical participation of it and the lack of a slender body or part of it” of its tone. "original".

التشوهات القوامية: وهو عبارة عن انحراف أو تغير في شكل عضو من أعضاء الجسم كله أو جزء منه عن الشكل الطبيعي المسلم به تشريحيا كما يعرف بأنه " اختلال في العملية التنظيمية لأجزاء الجسم وخروج مركز الجاذبية الأرضية عن الخط العمودي له وافتقار العضلات أو جزء منها لنغمتها الأصلية



أنها حالات انحراف عن الوضع الطبيعي لأجزاء الجسم حيث تكون هذه التشوهات إما مكتسبة وذلك عن طريق تعود الفرد على اتخاذ وضع خاطئ مما يتسبب عنة نمو بعض أجزاء الجسم بطريقة غير طبيعية فيحدث التشوه أو وراثية عند الولادة

تشوهات وراثية عند الولادة

تشوهات مكتسبة

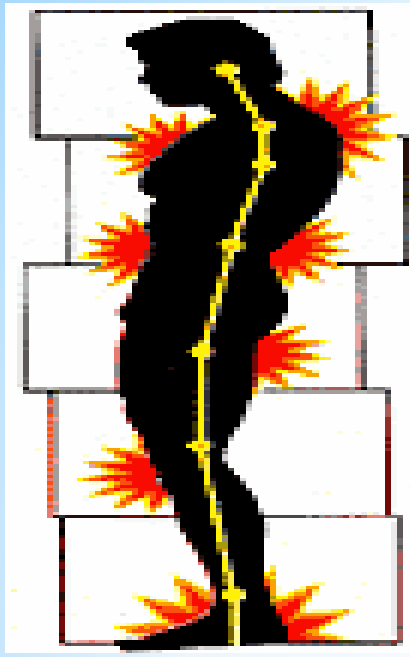


Congenital causes: They occur as a result of the wrong placement of the fetus in the mother's womb and the mother's use of certain drugs during pregnancy or as a result of the pregnancy or as a result of the mother's malnutrition. Its effect begins before the birth of the fetus. It may also be the result of genetic factors such as the transfer of certain characteristics from one of the previous generations to the fetus through The path of dominant genes To one of the parents.

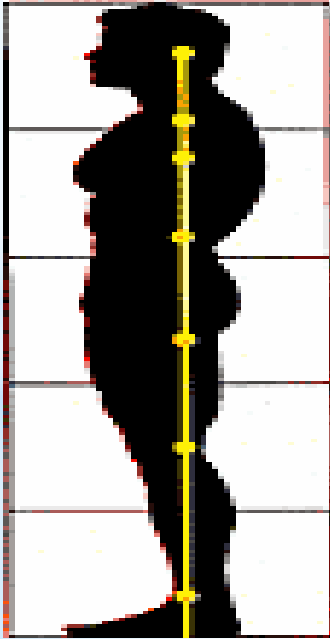
اسباب خلقية : وتحدث نتيجة للوضع الخاطئ للجنين في رحم الأم وتعاطي الأم لبعض العقاقير أثناء الحمل أو نتيجة الحمل أو نتيجة لسوء التغذية للأم ، ويبدأ تأثيرها قبل ولادة الجنين ، كما انها قد تكون نتيجة لعوامل وراثية مثل نقل صفات معينة من احد الأجيال السابقة إلى الجنين عن طريق الجينات السائدة لأحد الوالدين



التعريف التشريحي للقوام السليم " خط إتزان الجسم " هو الوضع الذي يمر فيه خط إتزان الجسم " خط ثقل الجسم " من الوضع الجانبي بداية من " نتوء حلمة الأذن " ليمر خلف فقرات الرقبة ثم أمام الفقرات الظهرية ثم أمام التمثفصل العجزي الحرقفي إلى مركز مفصل الفخذ ثم أمام مفصل الركبة ليسقط على قاعدة الإرتكاز " أمام مفصل الكعب



والانحراف القوامي يعرف بكونه : خلل في شكل عضو من أعضاء الجسم أو جزء منه، وانحرافه عن الوضع الطبيعي المعروف به تشريحياً، مما ينتج عنه تغير في علاقة هذا العضو ببقية أعضاء الجسم الأخرى. .



والقوام المعتدل يتطلب أن تكون أجزاء الجسم مترابطة بعضها فوق بعض في وضع عمودي، فالرأس والرقبة والجذع والحوض والرجلان يحمل كل منهما الآخر بما يحقق اتزاناً مقبولاً للجسم، وبما يحدث التوازن المطلوب في عمل الأربطة والعضلات وأجهزة الجسم المختلفة

للجسم قاعدتين إرتكاز هما

" الحوض ، القدمين

. خط الإتزان يقسم الجسم إلى نصفين

متساوين

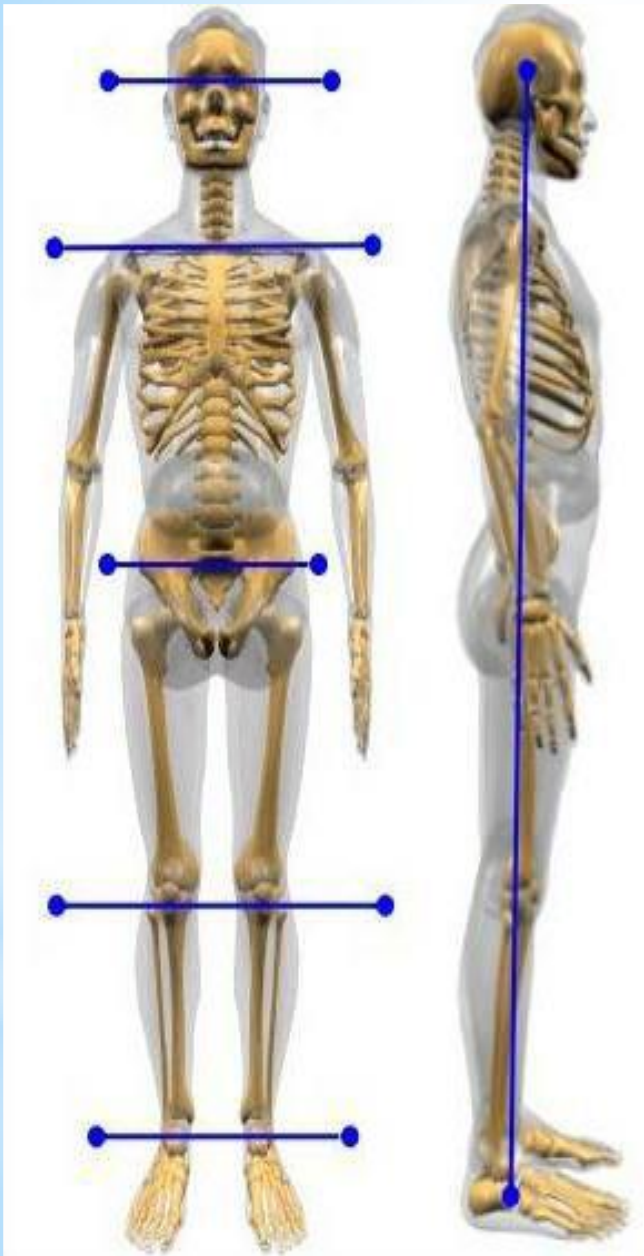
. و هناك ٤ خطوط في الجسم . وهم :

1. خط الكتفين

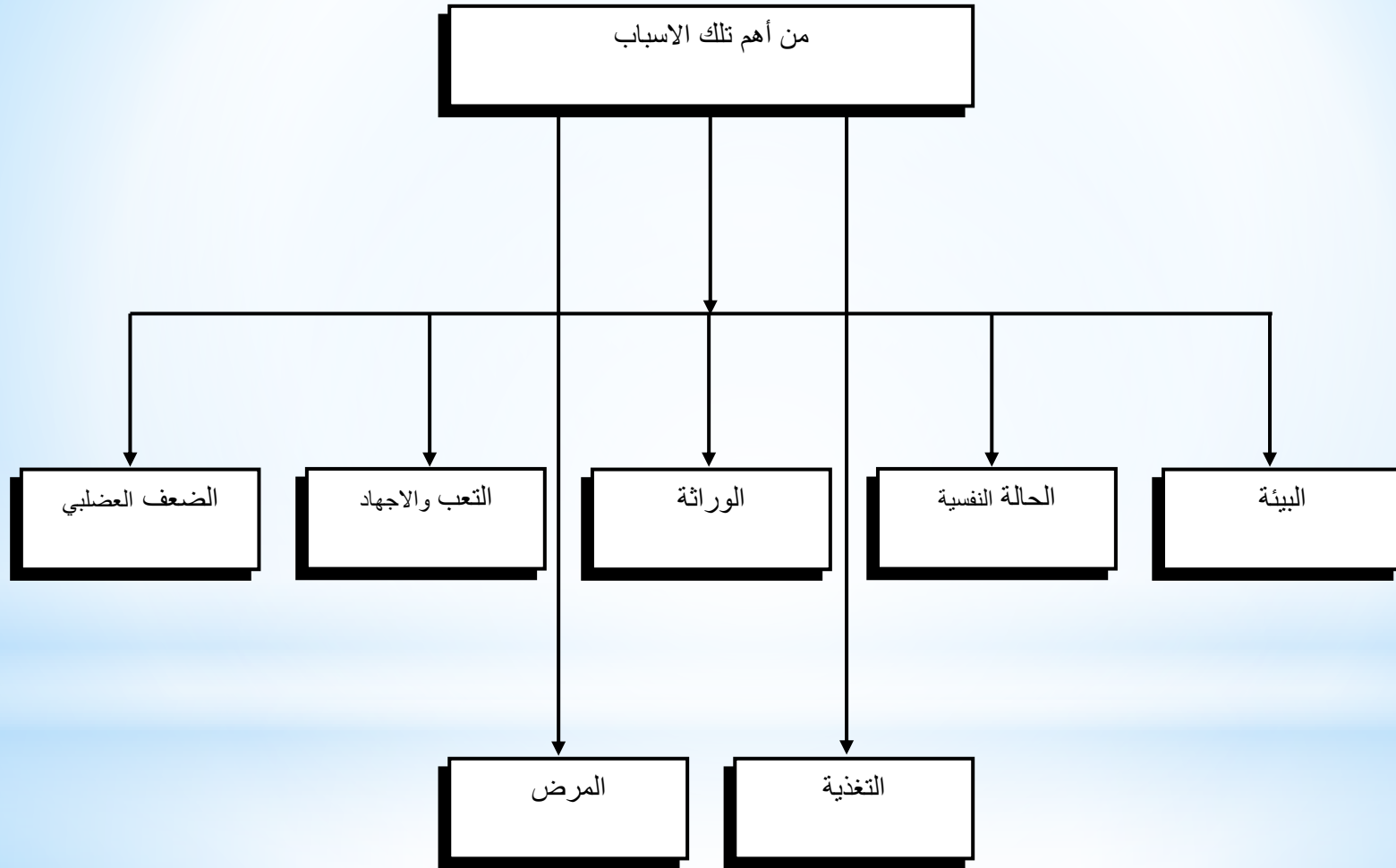
2. خط الحوض

3. خط الركبتين

4. خط الكعبين



اسباب الانحرافات القوامية:



ايضا من اسباب التشوهات القوامية



1. العيوب (الخلقية) التي يولد بها الإنسان:

إذ يبدأ تكوين هذه التشوهات في أثناء تكون الجنين، وهو من أخطر العوامل لصعوبة إصلاحها أو لا يمكن إصلاحها نهائياً.

2- الإصابة: في حالة إصابة عظمة أو عضلة أو رباط يختل الاتزان وإذا استمر الحال طويلاً فإن الجسم أو أجزاء منه تتخذ شكلاً خاطئاً للقوام.





3- المرض: إنّ الأمراض التي تصيب العظام أو العضلات أو التي تجعل المفاصل تفقد مرونتها وسهولة حركتها تؤثر في القوام.

4- الملابس الضيقة: تعيق أجهزة الجسم الحيوية عن القيام بوظائفها على خير وجه، فالحزام الضيق يعيق حركة الحجاب الحاجز فيتعطل التنفس والمشدات الضيقة تمنع الصدر من الاتساع في عملية الشهيق فتضعف العضلات وتقل مرونتها كما تقل مرونة المفاصل.





5- نوع العمل المهني أو البيئة

التي يعيش فيها الفرد: إذ يحدث

لبعض مزاوولي أنواع معينة من الألعاب
الرياضية كالسلاح وركوب الخيل أو

الظروف التي تتوافر للفرد مثل مقاعد
الدراسة التي لا تتناسب مع حجم التلاميذ

كذلك المساند والمراتب غير الصالحة أو
العيش في بيئه تتطلب اتخاذ أوضاع

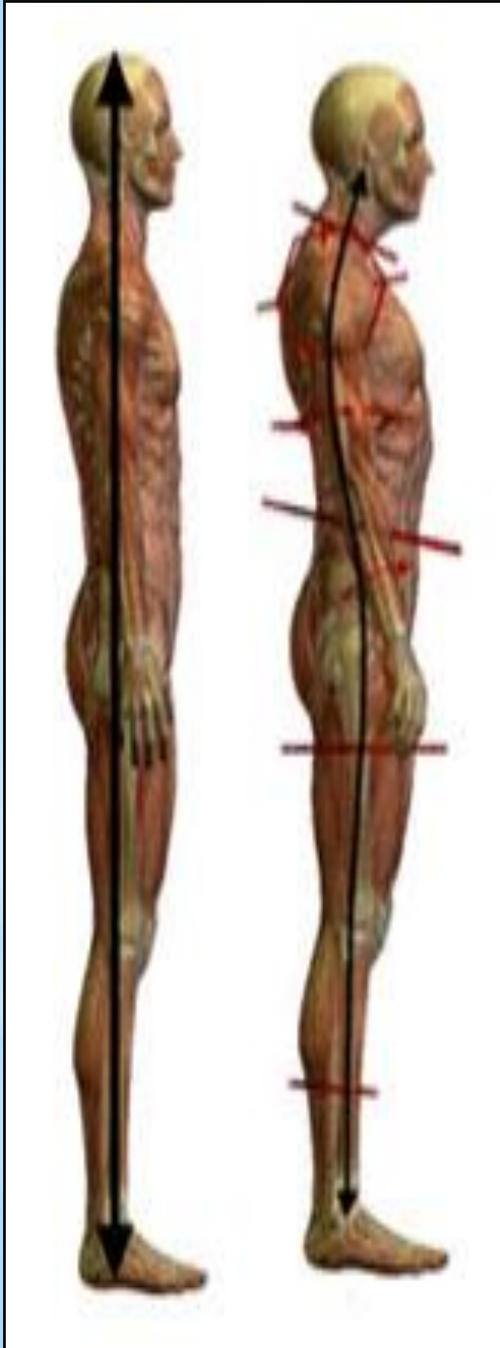
جسمية خاطئة لها تأثيرها الضار على
القوام.



أشكال القوام: -

القوام الوصفي يعتمد على الوصف الخارجي لأوضاع الجسم ويكون من خلال ترتيب أعضاء الجسم، بحيث تكون القدمان متباعدتين قليلاً ومتجهين للأمام أو للخارج قليلاً، ويرتكز معظم وزن الجسم على منتصف القدم وتكون الركبتان في حالة بسط و العمود الفقري يعمل كعمود متزن والوزن موزع حوله، ووضع الكتفين يكون للخلف قليلاً من أجل تركيز الوزن على العمود الفقري وليس على الصدر، والصدر مرتفع قليلاً دون اندفاع إلى الأمام، وتنقبض عضلات البطن بنغمتها العضلية المعتادة، أما الرأس فيكون في حالة استقامة واتزان دون اندفاع للأمام أو إلى الخلف





2. القوام التشريحي (Anatomical)

(definition): يعتمد على وضع الأجزاء

التشريحية للجسم بالنسبة لخط الثقل، إذ

تسمح هذه الأجزاء بمسار خط الثقل من

أية نقطة كانت، وعرفته (Dena

Gardiner) بأنه " سلوك أو تصرف

محقق من الجسم بمساعدة النغمة العضلية

أو بعمل العديد من العضلات للحصول على

التوازن أو لتشكيل قاعدة أساسية يتم

الاعتماد عليها للحركة "

العادات القوامية:-

أ. العادات القوامية الصحيحة:

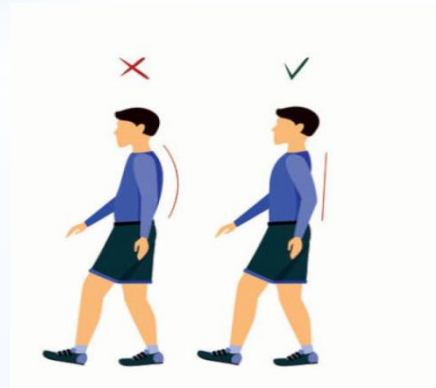
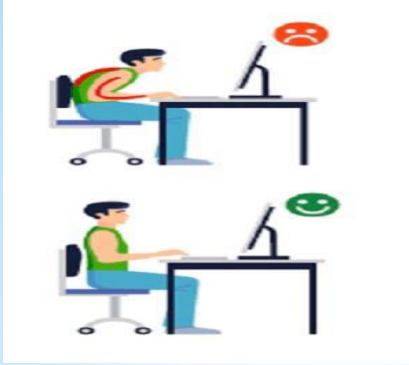
1. عند المشي تأكد ان يكون الجسم مفرد والقدمان للأمام.

2. عند الجلوس تأكد ان يكون الظهر مفرد وعدم الميل لأحد الجانبين واتزان الحوض كله على المقعد.

3. عند حمل الاشياء في اليدين اعمل على موازنة

الاشياء باستخدام اليدين.

4. عند رفع الاشياء من الارض اثني الركبتين مع المحافظة على وضع الجسم مفرد



ب. العادات القوامية الخاطئة :

1. الوقوف غير السليم والجسم المترهل يشكل ضغط على المفاصل.

2. المشي والجسم غير مفروود والقدمان للخارج.

3. الجلوس على كرسي مقعر مما يحدث شد لأعلى الظهر والرقبة.

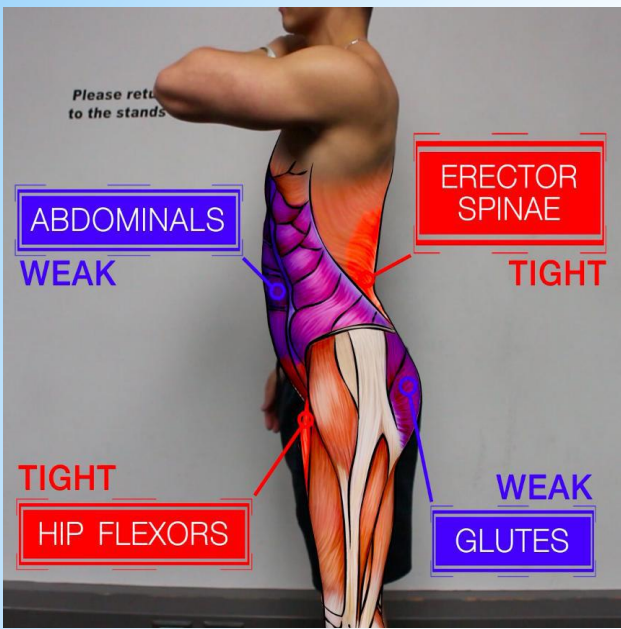
4. الجلوس على كرسي مرتفع جدا يسبب شد في الظهر والرقبة.

5. الجلوس على مسافة كبيرة من ظهر الكرسي يحدث شد في الذراعين والظهر.

6. ارتداء الحذاء الضيق وبكعب عالي يحدث شد للرجلين والحوض واسفل الظهر.



اعراض التشوهات القوامية



1- تمتد الاربطة

2- قصر القامة

3- الضغط غير المتكافئ على الغضاريف

والمفاصل مما يؤدي الى تهتك الغضاريف

والمفاصل والخشونة مع تقد العمر

4- قصر العضلات وسهولة الاصابة بالتمزقات

العضلية

5- ضعف العضلات وعدم استجابتها للتقويات

العضلية

العضلات القصيرة

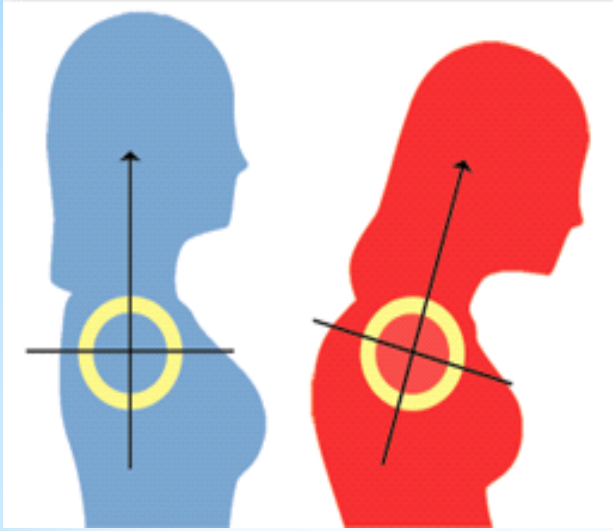
1- العضلة القطنية

2- عضلات اسفل الظهر

العضلات الضعيفة

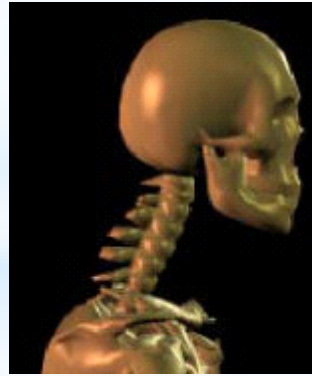
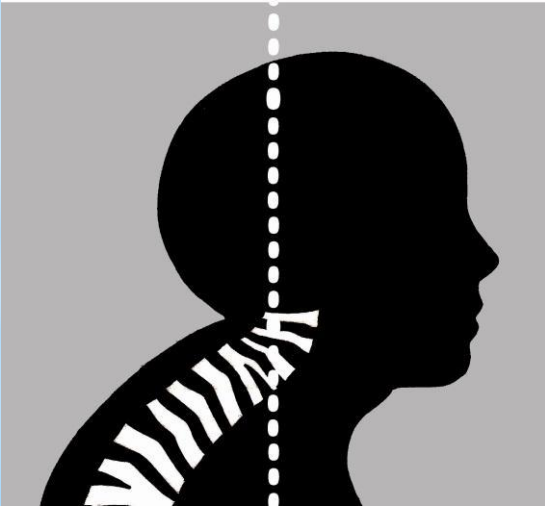
1- عضلة المقعدة

2- عضلة اسفل البطن



انحراف الرأس

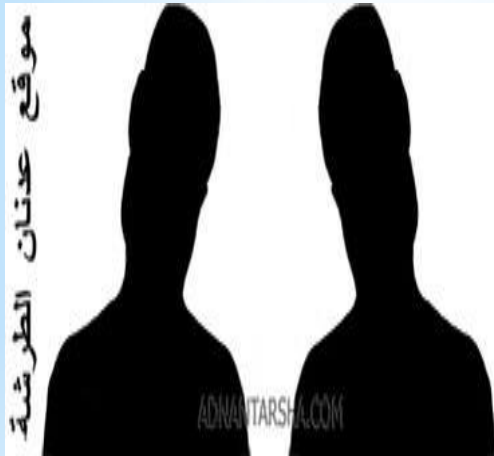
- هناك أنواع مختلفة لانحراف الرأس وهي
 - ميل الرأس لجهة اليمن أو اليمين
 - سقوط الرأس للأمام أو للخلف .



وهذه الانحرافات هي نتيجة لانحرافات
بالفقرات القطنية للعمود الفقري

ميلان الرأس الجانبي:

وهو ميلان الرأس جانباً لأحد الجهتين، في حالة ميله إلى جهة اليمين حصلت حالة انحراف الرأس إلى اليمين (R.T) ويستخدم رمز (L.T) للإشارة إلى انحراف الرأس إلى اليسار (Left Tilt, Right Tilt) ومع استمرار الحالة وطول فترة الانحراف فإن ذلك يسبب قصر عضلات الرقبة وصلابتها في جهة الانحراف وطول ورخاوة العضلات في الجهة المعاكسة للانحراف





صعوبة الالتفاف:

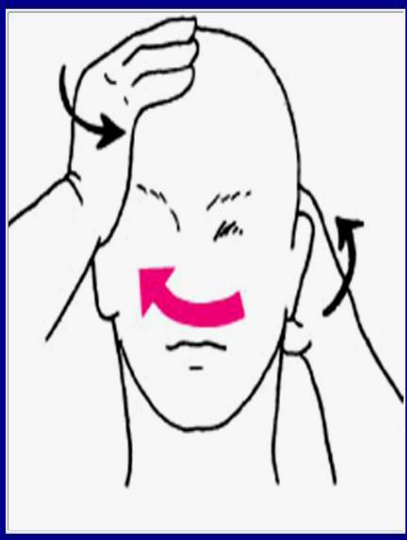
وهي الحالة التي يكون سببها قصر عضلات الرقبة والخاصة بتدوير الرأس في جانب واحد، مما يجعل الرأس في وضع متلفت إلى أحد الجانبين مؤديةً إلى صعوبة الاستقامة الاعتيادية إلى الأمام



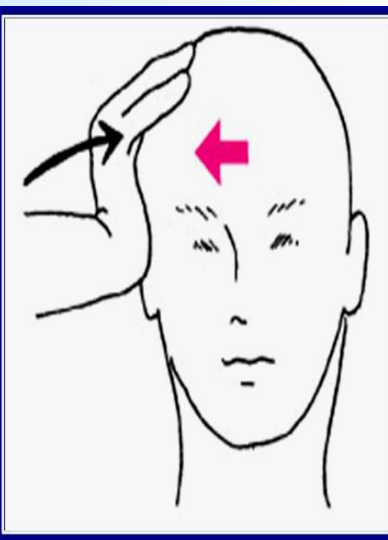
أسباب : انحراف الرأس

- 1- الجلوس إلى المكتب والكتابة مدة طويلة
- 2- عادات الخجل عند البنات والمراهقات طوال الأجسام ومحاولتهن إخفاء ذلك بثني الرأس .
- 3- بعض المهن التي تتطلب اتخاذ أوضاع تساعد على تشوه الظهر .
- 4- الخلل العضوي ف إحدى العينين او الاذنين أو قصر إحدى الرجلين عن الأخرى أو تفلطح في إحدى القدمين
- 5- المشي مع توجيه النظر لأسفل باستمرار .
- 6- الجلوس الطويل امام التلفاز وخاصة باوضاع خاطئة.

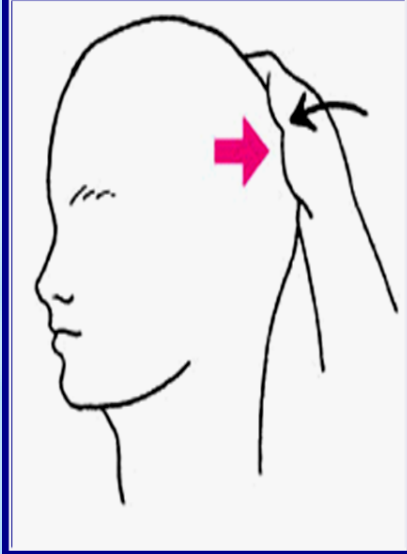




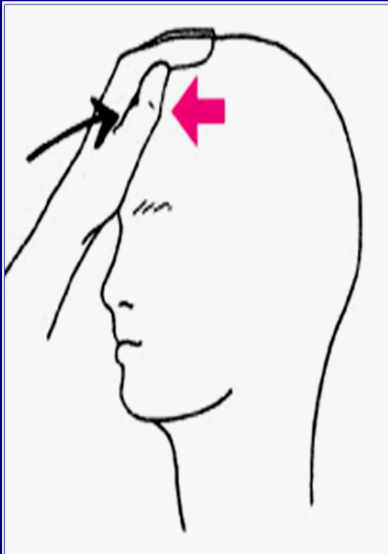
الدوران



الشئ للجانب



الشئ للخلف



الشئ للأمام

التمارين العلاجية

- 1 - تحرك الرقبة برفق في جميع الاتجاهات بحركة دائرية.
- 2 - إمالة الرقبة مرة إلى اليمين ومرة إلى اليسار.
- 3 - تدفع الرقبة ببطء إلى الخلف.
- 4 - ثم تحرك ببطء ايضا و يتم إمالتها للأمام ناحية الصدر

التشوهات القوامية للعمود الفقري:



هناك انحناءات شاذة للعمود الفقري لها تأثير مباشر في القوام الذي يرجع سببه الى عوامل وراثية او الى المؤثرات البيئية المبكرة ، لذا فأن هذه التشوهات القوامية تحد من عمل العمود الفقري وتعيق العمل الوظيفي للأعضاء والاجهزة المرتبطة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالعمود الفقري.





التحذب الظهرى: Kyphosis

يعد هذا التشوه من التشوهات الشائعة التي تصيب العمود الفقري بمرحلة مبكرة من مراحل الطفولة . لذا يمكن تعريف التحذب الظهرى على انه "الوصف المبالغ للانحناء السهمي الموجود في المنطقة الصدرية من العمود الفقري

فهناك تأثيرات سلبية للتحذب الظهرى في الخصائص الوظيفية لجسم الفرد وله تأثيرات في العضلات والاربطة مما يزيد من طول عضلات المنطقة الظهرية باتجاه الخلف بينما تقصر العضلات والاربطة المقابلة لها في المنطقة الامامية للعمود الفقري



تحدب الظهر هو عبارة عن زيادة غير عادية في تحدب العمود الفقري في المنطقة الظهرية للخلف مما يتسبب عنها دوران الظهر . وهذا التشوه يمكن ان يتخذ شكله ومظهره في اي فترة من فترات الحياه ولكنه شائع الظهور في مرحلة الطفولة والمراهقة وعند كبار السن وهو اكثر انتشارا بين تلاميذ المدارس واصحاب المهن التي تتطلب الجلوس علي المكاتب لفترة طويلة

Humpback deformity: It is an unusual increase in the curvature of the spine in the dorsal region, causing the back to rotate. This deformity can take its shape and appearance at any period of life, but it commonly appears in childhood, adolescence, and in the elderly. It is more common among schoolchildren and those in professions that require sitting at desks for a long time.

أسباب التشوه : 1- مرحلة الطفولة المبكرة والمتأخرة :

- العادات السيئة مثل الوقفة الخاطئة او الجلوس الطويل
الخاطئ أمام التلفاز .

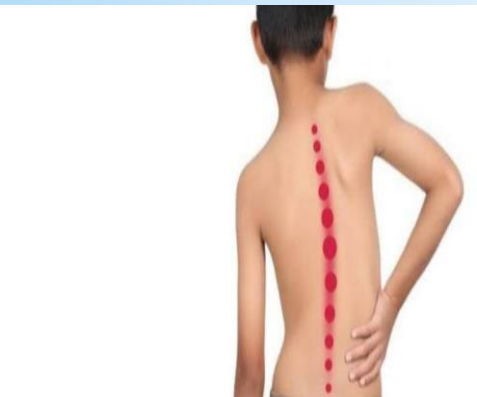
- بعض أمراض الجهاز التنفسي التي تسبب ضيق القفص
الصدري وتسطحه فينحني الظهر

- ضعف النظر وقصره .

- خلل في منحنيات العمود الفقري .

- مرض الكساح ولين العظام وتضخم مفصل الورك (ضلع
المفصل الولادي)

- ضيق الملابس .



مرحلة المراهقة والشباب :

- العادات السيئة .

- بعض الأمراض الروماتيز و امراض الرئة والشلل .

- بعض الأعمال المكتبية .

- الخجل عند النساء .

نتيجة لتشوهات قوامية أخرى مثل سقوط الأكتاف او سقوط الرأس إماما .

الحوادث والإصابات الأخرى .

الخجل عند المرأة



3- مرحلة الشيخوخة :-

بعض الاسباب سابقة الذكر في المرحلتين
السابقتين .

- ضعف العضلات .

- تأكل غضاريف الفقرات او الغضاريف نفسها .

- قد يكون ناتجاً عن تغيرات وظيفية وبنوية في
اجسام الفقرات .



علاج التحذب الظهرى

- تستخدم التمرينات العلاجية والوسائل الاخرى في علاج التحذب الظهرى وذلك بهدف : (تقوية العضلات للظهر والبطن ، وتحسين القوام علاوة على تحسين الوظيفة التنفسية)
- كذلك يستخدم المساج والسباحة على الظهر لتقويم التحذب الظهرى .
- فضلاً عن استخدام وسائل العلاج الطبيعى الفعالة .
- استخدام العلاجات التجبيرية في الحالات الحادة .



استدارة الكتفين وتسطح الصدر



الحالة الطبيعية

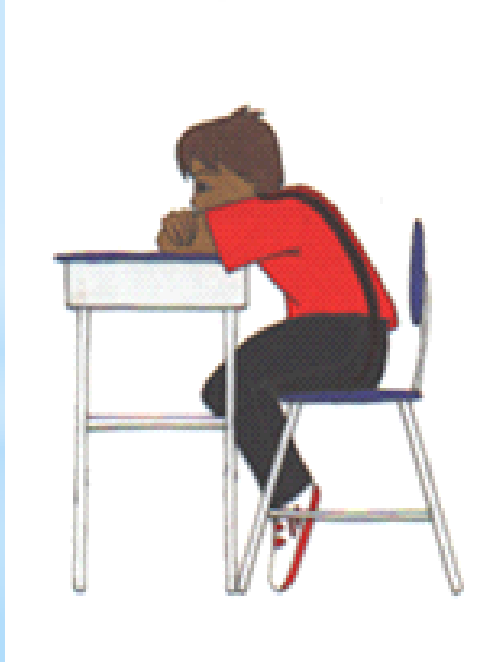


استدارة الكتفين

استدارة الكتفين وتسطح الصدر عبارة عن انحراف الجزء العلوي للعمود الفقري مصحوبًا بتدوير الكتفين للأمام مع ميل الرأس أمامًا أسفل مما يؤدي إلى ضيق القفص الصدري وضعيف ذلك من مقدرة الشخص على أخذ التنفس العميق الملائم.

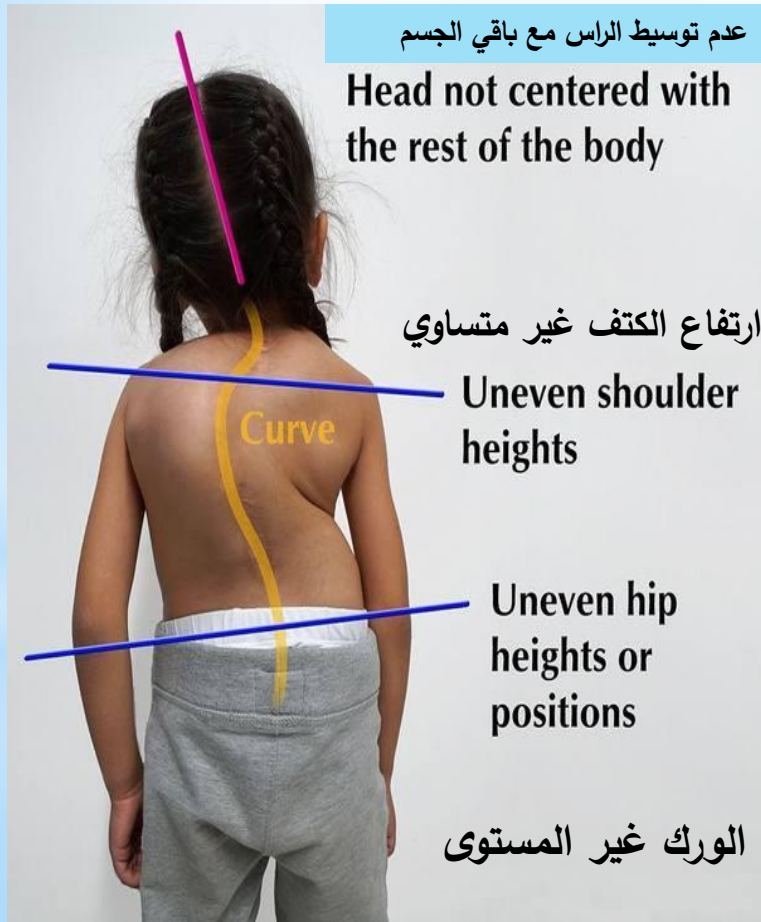
أسباب استدارة الكتفين وتسطح الصدر

ترجع أسباب التشوه إلى العادات القوامية السيئة كذلك الأعمال اليومية تلعب دورًا مهمًا في هذا الانحراف وخاصة الأعمال التي تتطلب خفض الرأس أمامًا كالكتابة والقراءة والعمل على الحاسوب والحياسة... وعمومًا جميع الأعمال التي يستخدم فيها الذراعان أمام الجسم.



الانحناء (الانحراف) الجانبي: Scoliosis

الانحناء الجانبي اذ عرفه على انه انحراف العمود الفقري عن الخط الشاقولي للجسم الى احد الجانبين (ايسر - ايمن - او كليهما)



أعراض الإنحناء الجانبي للعمود الفقري



إختلال توازن الكتفين

منحنى في العمود الفقري

إختلال توازن الحوض

اسباب التشوه

بعض المهن التي تتطلب ثني الجذع لاحد الجانبين لمدة طويلة

بعض الامراض كلين العظام وشلل الاطفال

نتيجة لبتر احد الذراعين

نتيجة الالم الشديد في احد الجانبين

نتيجة العادات السيئة في الوقوف والجلوس

الوراثة .



علاج الانحراف الجانبي

ان الغرض او الهدف الاساسي من وراء علاج هذا التشوه وذلك لتقوية عضلات القوام وخاصة عضلات الظهر والبطن ، وتقوية الانحراف مع منع زيادته او حدوث ضمور عضلي ، فضلاً عن تقوية عضلات الجهاز التنفسي لزيادة الكفاءة الرئوية



تستخدم التمرينات العلاجية التي تعتبر من اهم الوسائل العلاج والتأهيل لتقويم الانحناء الجانبي واستخدام السباحة وتمارين العقلة مع مرجحة الرجلين والتعلق كلياً لتحسين التوازن وتكون هذه التمرينات لتمطية العضلات الجانبية



الام أسفل الظهر (Low Back Pain):



هو واحد من الشكاوى الشائعة لدى كثير من الناس وخاصة البالغين ومعظم هؤلاء الناس قد يحدث لهم في وقت من الأوقات ألم أسفل الظهر، الذي يتمثل بحدوث تعب يشعر به الشخص في منطقة الظهر (الوسطى - السفلى)، وقد يمتد منطقة الفخذ والسيقان.



والظهر متكون من تنظيم معقد من العظام (الفقرات) والأربطة والمفاصل والعضلات لذلك فحدوث ألم به قد ينشأ من أي مشكلة تصيب هذه المكونات، كما وحدوث آلام أسفل الظهر هو الأكثر شيوعاً لأن منطقة أسفل الظهر هي المعرضة لضغط كبير في كثير من الحالات

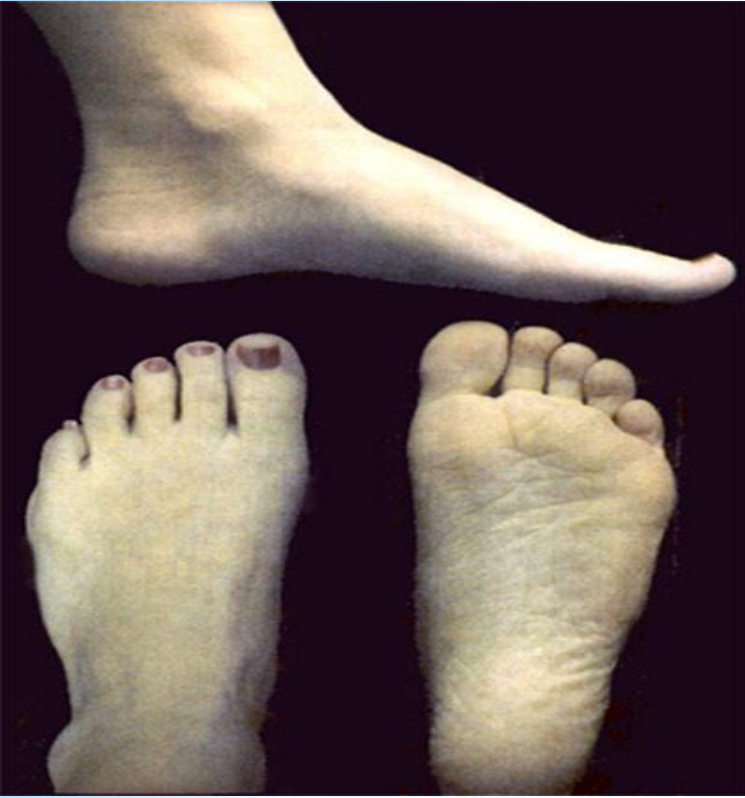
تشوهات الأطراف السفلى



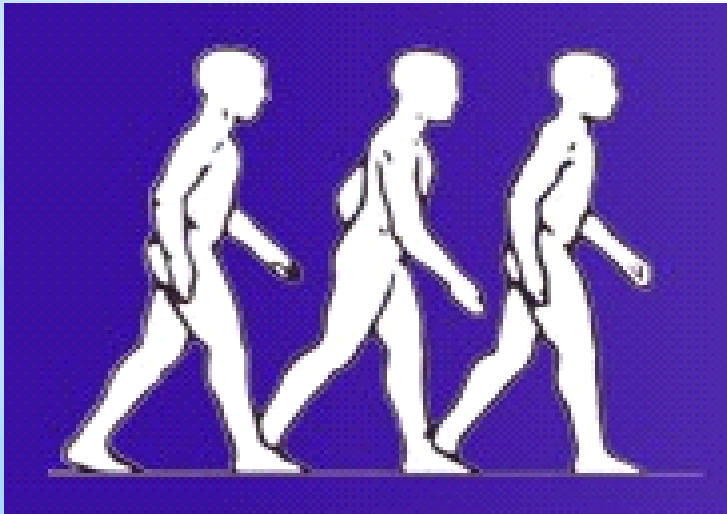
وهو نوع من التشوهات التي تصيب الطرف السفلي من (مفصل الورك أي عظمة الورك - الفخذ - الساق)، وهذه المنطقة ذات تأثير كبير على الرياضي بسبب الدور المهم الذي تلعبه عضلات (الفخذ، الورك) في أي نشاط حركي، وعادة ما تكون هذه نتيجة الولادة أو بسبب إصابة الفرد بمرض ممكن أن يسبب في حدوث هذا النوع من التشوه، ويكون هذا التشوه بعمر (3 - 5) سنوات فسيولوجياً وبعدها يصبح حالة مرضية ويمكن أن يصيب الساق أو الساقين معا



تسطح القدم



أن هيكل جسم الإنسان مصمم بطريقة هندسية ومعمارية ربانية وبشكل متوازن، فهو عبارة عن "أجزاء متراسة فوق بعضها البعض، فهي كالمكعبات المتراسة في نظام دقيق، فإذا انحرفت هذه المكعبات عن وضعها الطبيعي أصيب الفرد بما يعرف بالتشوه



متاعب القدمين

تشير الاحصائيات إلى أن 85 ٪ من متاعب القدم سببها إساءة استخدام الاحذية

15% اسباب اخرى كالعادات السيئة

ويقصد بالحذاء غير المناسب (الحذاء الضيق ، او الواسع، او العالي)

الحذاء الضيق

يضغط على أصابع القدمين ويسبب لها كثيرًا من الآلام ويغير من تنسيقها، واستقامتها، ويؤدي إلى التهاب الكيس الزلالي لمفصل القدم.



الحذاء الواسع

يعوق حركة القدم، ويسبب الجروح والالتهابات في
عقب القدم بسبب احتكاكه بالجدار الداخلي للحذاء.



الكعب العالي

يجعل الجسم مرتكزاً بكل ثقله على أصابع القدم
وبالتالي تتغير أوضاعها، وتفقد استقامتها،
ويصاب الجسم بفقد الاتزان مما يؤثر على وضع
الحوض والعمود الفقري.



المتاعب التي يسببها تفلطح القدمين



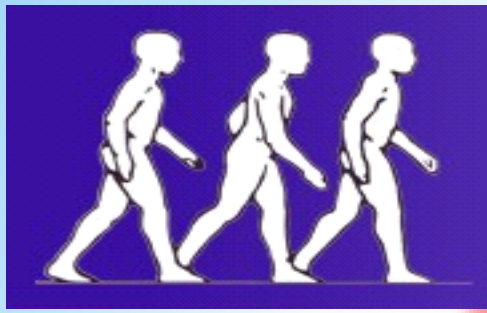
تمارين العلاجية

رفع العقبين عن الأرض للوقوف على أصابع القدمين.

المشي في المكان مع عدم ترك المشطين للأرض

الوثب في المكان بالدفع بالمشطين.





بعض الإرشادات التعليمية للقوام الجيدة

1. القدمان : القدمان أماما ، ثقل الجسم موزع على القدمين.

2. الركبتان : الركبتان مفرودتان بغير تصلب .

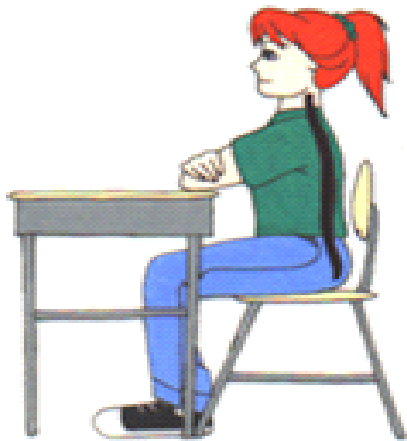
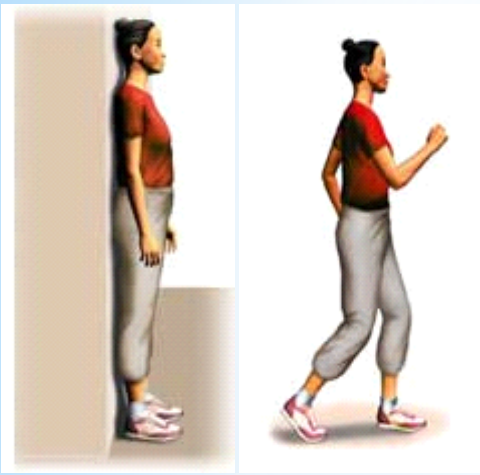
3. أسفل الظهر والبطن : يجب وضع المقعدة في نهاية المقعد الدراسي ، عدم دفع الحوض للأمام و استقامة الظهر جذب البطن للداخل و استقامتها .

4. الجزء العلوي للجسم : الصدر مفرودا و لأعلى .

5. الرقبة والرأس : الرأس لأعلى ، الذقن لأسفل وغير متصلبة ، النظر للأمام .

6. المشي : الجسم مفرد أثناء المشي ، القدمان للأمام ، النظر أمام ، استرخاء الذراعين.

7. الجلوس : الظهر مفرد ، عدم الميل لأحد الجانبين ، اتزان المقعدة كلها على المقعد.



مبادئ و إرشادات العناية بالقوام

التغذية الجيدة مع التركيز على المكونات الغذائية التي تدخل في تركيب العظام و خاصة الألبان ومشتقاتها لما تحتويه من املاح الكالسيوم بالإضافة إلى الأسماك والبروتينات بشكل عام خاصة في المراحل الأولى من العمر مع التأكد على اهمية الوجبة المتوازنة للطفل.

اهتمام الأسرة بعمليات الفحص الدوري الشامل على الطفل و متابعة نموه الطبيعي بصفة عامة و نموه الجسم بصفه خاصة



الإصابات الرياضية:



يعد علم الإصابات الرياضية أساساً في تطوير قابلية الرياضي ووقايته من الإصابات, لأن معرفة سبب حدوث الإصابة يجعل المدرب ملماً بطرائق تفاديها وتوفير الأمان و السلامة أثناء النشاط الرياضي, فإن علم الإصابات يرشد المدرب أو المعالج إلى اتخاذ الإجراءات المبكرة واللازمة للإسعافات الأولية ونقل المصاب إلى المراكز العلاجية بطرائق سليمة بدون مضاعفات

. Contact injuries occur in sports involving at least two players or during team sports that involve contact or collision. Physical friction can lead to injuries to muscles and ligaments, as they are forced out of position or torn. The most common sports in which this type of injury occurs are football, basketbal.

تحدث الإصابات الناتجة عن الاحتكاك في الرياضات التي يشارك فيها لاعبان على الأقل أو أثناء الرياضات الجماعية التي تنطوي على الاحتكاك أو التصادم. ومن الممكن أن يؤدي الاحتكاك الجسدي إلى حدوث إصابات في العضلات والأربطة حيث يتم إجبارها على الخروج من موضعها أو تعرضها للتمزق. ومن أكثر الرياضات شيوعا التي يحدث فيها هذا النوع من الإصابات كرة القدم وكرة السلة

مفهوم الإصابة:

بأنها " تمزق أو اختلاف في ترابط نسيج أو أكثر من أنسجة الجسم (عضلات، أوتار، عظام، أربطة) وغيرها من الأنسجة الأخرى نتيجة لتأثير عوامل ميكانيكية داخلية أو خارجية على ذلك النسيج



إذ إن الإصابة ليست مصطلحاً عابراً وإنما هي تراجع في مستوى أداء او عمل أعضاء الجسم من العضلات أو الأنسجة الرابطة أو الأعصاب أو الخلايا الدموية وغيرها نتيجة تمزقها أو تلف قسما من خلاياها مما يجعلها تطرح الفضلات الخلوية لتعريف الجسم بحدوث الإصابة

أهم أسباب الإصابات الرياضية بصورة عامة

1- التدريب الخاطئ غير المدروس، إذ يؤدي هذا التدريب إلى حدوث الإصابة للأسباب الآتية

- أ- عدم الاهتمام بتنمية عناصر اللياقة البدنية كافة والاهتمام بجزء منها.
- ب- عدم تكامل تدريب جميع المجموعات العضلية المشتركة في الأداء
- ت- سوء تخطيط البرنامج التدريبي إذ يجب أن يكون التدريب قبل المباراة بيوم واحد تدريباً خفيفاً، وقد يفضل الراحة في بعض الحالات كما يجب تناسب شدة وحجم الحمل تناسباً عكسياً والا يتعرض اللاعب للإرهاق العضلي واحتمال الإصابة .
- ث- عدم الاهتمام بالإحماء الكافي والمناسب للعبة.
- ج- عدم ملاحظة المدرب للاعب بدقة إذ إن الملاحظة الدقيقة تجنب اشتراك اللاعب المصاب نفسياً أو بدنياً.



2- سوء المستلزمات الطبية: وتشمل ما يأتي

أ- عدم ملائمة أرضية الملعب.

ب- عدم الاستخدام الصحيح والمناسب للأدوات الرياضية.



3- مخالفة القوانين الرياضية كمهاجمة اللاعب والاعتداء عليه وما شابه ذلك.

4- سوء الحالة النفسية والخلقية للاعب والابتعاد عن الروح الرياضية نتيجة للتوجيه الخاطئ من قبل المدرب كالعنف والخشونة والانفعال النفسي الزائد والمبالغ فيه.

5- عدم الراحة الكافية التي تتمثل بين التمارين الرياضية أو النوم لمدة كافية.

6- استخدام المنشطات يؤدي إلى إجهاد وظيفي يعرض اللاعب لكثير من الإصابات.

7- عدم الأخذ بنتائج الفحوصات والاختبارات الطبية الخاصة بتقييم اللاعب فسلجياً وجسماً.



الإصابات الرياضية الشائعة



إصابات العضلات:

إصابات العضلات بأنواعها المختلفة تُعدّ من الإصابات الأكثر انتشارًا وحدوثًا بين الرياضيين، وقد تصل معدلات حدوثها حوالي (90%) من الإصابات المختلفة، ويرجع ذلك إلى أن العضلات هي الأداة الرئيسة المنفذة لمتطلبات الأداء البدني الرياضي، وهو مكون رئيس في الجهاز الحركي للإنسان



الشّد العضلي : هو حالة من التوتر يصيب العضلة فيعوق ليونتها ومطاطيتها، ومن ثم تفقد العضلة المصابة أحد الخصائص اللازمة التي تساعد على التوافق في العمل مع باقي العضلات

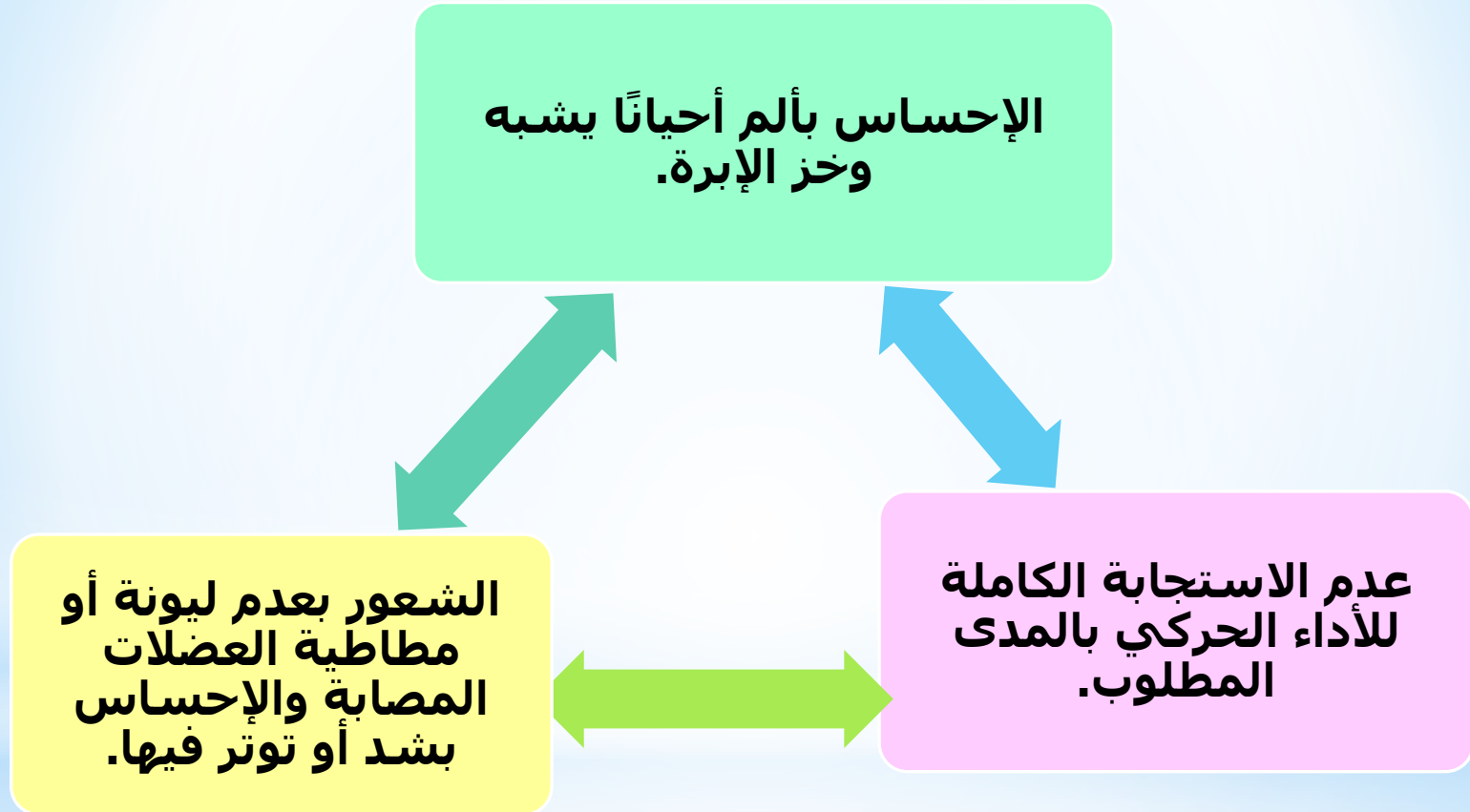
التقلص العضلي : عبارة عن انقباض تشنجي لا إرادي مستمر وقوي مصحوب بالآلام تصيب عضلة أو مجموعة، وقد يكون التقلص العضلي أثناء أداء المجهود البدني العضلي أو أثناء الراحة أو حتى أثناء النوم.

التشنج العضلي هو رد فعل عصبي مفاجئ يحدث تقلصا شديدا مؤلما أكثر من شدة التقلص الاعتيادي، ويستمر إلى ثواني أو دقائق معدودة وذلك خلال أو بعد إحماء العضلة. والتشنج العضلي تقلص قوي جدا وأكبر من المعتاد نتيجة لرد فعل عصبي وقد يستمر ثواني إلى دقائق معدودة ولاسيما بعد الإجهاد العضلي وهو مؤلم جداً، ويعد تشنج العضلات من الإصابات كثيرة الحدوث عند الرياضيين

✗ الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الشد والتشنج والتقلص العضلي:



✕ أعراض الشد والتقلص والتشنج العضلي:



✘ إسعاف وعلاج الشد والتقلص والتشنج العضلي:

- يبتعد المصاب عن المشاركة التنافسية سواء في التدريب أو المقابلات الرسمية.
- التدليك العلاجي السريع لإعادة ليونة ومطاطية العضلة.
- تمرينات علاجية تعتمد الإيقاع الهادئ واستعادة مطاطية وليونة العضلات المصابة تدريجيًا.
- حمامات مياه دافئة (أو كمادات مياه دافئة) لتنشيط الدورة الدموية.



التمزق العضلي



إن إصابة التمزق العضلي عبارة عن شد أو تمزق الألياف العضلية أو الأوتار نتيجة جهد عضلي عنيف أكبر من تحمل العضلة ومن أسبابها التقلص العضلي غير الاعتيادي الذي ينشأ من عدة عوامل منها عدم تناسق الانقباض بين مجموعتين من العضلات تعاكس بعضها في العمل وتراكم النواتج الثانوية في العضلة والناجمة من التقلص العضلي وعدم الإحماء الكافي للمجاميع العضلية, أو عودة اللاعب قبل تمام شفاؤه من شد أو تمزق عضلي سابق أو الانقطاع عن التمرين لمدة طويلة.

✕ علاج التمزق العضلي:



يكون العلاج في اليوم الأول باستخدام كمادات الثلج لمدة (20) دقيقة وكذلك في اليوم الثاني مع استخدام دوامات الماء لمدة (10) دقائق لحين اختفاء الألم مع رفع الجزء المصاب إلى أعلى وربطه بلفاف ضاغط (باندج) لتقليل النزف الداخلي الناتج ومنع حصول تورم و التدليك فقط أعلى وأسفل المنطقة المصابة لمدة (5) دقائق ثلاث مرات يوميا ثم نقوم بتأهيل اللاعب ببعض التمرينات لحين شفاؤه، أما إذا كان التمزق شديدا فيجب إجراء عملية جراحية لخيطة العضلة الممزقة.



Recovering from traumatic injuries: Treatment should begin immediately, by applying ice and applying pressure to the affected area to help prevent bleeding, bruising or swelling (wrapping the ice with a damp towel to protect the skin), while trying to raise the injured body part. You must continue applying ice for 48 hours. The first after the injury for 15 minutes each time. You should also try to move the affected part of the body gently on the same day, and after the first few days, once the swelling is controlled.

التعافي من الإصابات المؤلمة: يجب أن يبدأ علاجها على الفور، وذلك بوضع الثلج، وضغط المنطقة المصابة للمساعدة على منع النزيف والكدمات أو التورم (لف الثلج بمنشفة رطبة لحماية الجلد)، مع محاولة رفع جزء الجسم المصاب، يجب الاستمرار في وضع الثلج خلال الـ 48 ساعة الأولى بعد الإصابة لمدة 10-15 دقيقة في كل مرة. كما يجب محاولة تحريك الجزء المصاب من الجسم بلطف في اليوم نفسه، وبعد الأيام القليلة الأولى بمجرد السيطرة على التورم

من خلال اطلاع الباحثة على المصادر العلمية
توصلت الباحثة الى إن اغلب الأطفال يصابون
بانحراف في العمود الفقري الى اليمين أو اليسار وذلك
كنتيجة للأسلوب الخاطئ لحمل الحقيبة المدرسية
الثقيلة على الكتف الأيمن أو الأيسر أو على الظهر
وكذلك يصابون بسقوط الراس للأمام واستدارة الكتفين
والتحديق الظهرى بسبب الجلوس بوضع خاطئ
لساعات طويلة امام الحاسوب او التلفاز او الكتابة
بوضع منحني او بسبب المقاعد الدراسية التي لا
تتناسب مع عمر التلاميذ.

اما الانحناء الجانبي تعرفته الباحثة به هو خروج العمود الفقري عن الشكل الطبيعي في اتجاه واحد مصحوب بتحدد حركي يقلل من وظيفته.

اما الاصابات الرياضية عرفتها الباحثة بانها حالة حادة أو مزمنة يتعرض لها الجسم نتيجة إلى جهد عالي الشدة أو حركة مفاجئة تفوق قدرة ذلك الجسم مما يؤدي إلى تلف أو توقف أدائه بشكل كامل أو جزئي

عناوين دراسات سابقة

ت	السنة	العنوان	الجامعة	اسم الباحث
1	2005	الاصابات الشائعة للطرف العلوي لدى رياضي اندية محافظات نينوى وعلاقتها بالمتغيرات الانثروبومترية (الطول ، الوزن ، العمر التدريبي)	الموصل دكتوراه	فاطمة حسين عويد
2	2010	تأثير منهج تأهيلي لبعض التشوهات القوامية المترابطة للجزء العلوي من الجسم لتلاميذ المدارس الابتدائية باعمار (7-8) سنوات	بغداد ماجستير	صلاح محمود سلمان الدليمي
3	2004	التمرينات العلاجية للانحراف الجانبي للعمود الفقري المكتسب وتسطح القدم الاحادي الوظيفي	بغداد دكتوراه	صالح بشير ابو خيظ
4	2019	تأثير تمرينات بدنية في تطوير المحاميع العضلية للذراعين للوقاية من بعض الاصابات الشائعة لناشئي الريشة الطائرة	تكريت ماجستير	عمر ذباب مناوي الراشدي
5	2017	اثر تمرينات تأهيلية وفق التحليل التشريحي لبعض التشوهات القوامية وباستخدام وسائل مساعدة في اهم المتغيرات البايوكينماتيكية والبدنية والحركية للتلاميذ بأعمار (6_8) سنوات الكوفة	ماجستير الكوفة	حنان نعمان هادي العلياوي

المصادر

1. Rheumatology, Annals of the rheumatology diseases, supplement eular,2000

2. M. Dena Gardiner; **The principles of exercise therapy**. 4th EdR. V. printrs –Bhola–vathe –Nagarshahadara Delhi , 1995

3. Jeffrey A. Russ ; **Tennis Injuries Causes and Methods of Prevention**,(Usa, Library of Congress Vol.(5),2006.)

4. حكمت حسين وآخرون: تشوهات القوام وعلاجها بالتمارين. مصر: النيل للتوزيع والنشر، 2000

5. سهاد حسيب عبد الحميد : تأثير برنامج علاجي لتشوهات التحدب الظهري في بعض المهارات الاساسية . رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد

6. سميرة خليل محمد ؛ الإصابات الرياضية: (وزارة التعليم العالي ،جامعة بغداد،2005)

7. بزار علي جوكل ؛ مبادئ واساسيات الطب الرياضي، ط1: (الاردن، دار دجلة، 2009)

8. خالد احمد الروبي؛ برنامج بدني مقترح كأساس لتجنب بعض اصابات ناشئي الريشة الطائرة: (رسالة ماجستير, كلية التربية الرياضية, جامعة بني سويف, 2016)

9. زكريا حسن شحاتة ؛ تنمية بعض المتغيرات البدنية والمورفولوجية وعلاقتها بحدوث الاصابات الرياضية لناشئي الجمباز: (اطروحة دكتوراه, كلية التربية الرياضية, جامعة طنطا, 2004)

10. وعد عبد الرحيم فرحان؛ التقويم التشخيصي لبعض تشوهات القدمين الوظيفية باستخدام جهاز بودياسكوب المعدل، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية، 2001